

NOTULEN

Yang dilaksanakan pada : Kamis / 14 Maret 2024
Pukul : 10.00 WIB – SELESAI
Materi : Laporan Bulanan Februari
Tempat : Hall Sakura Lantai 5

Berikut hasil notulen :

NO.	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	Go green	Mealbox dokter	Mealbox di rubah menjadi kertas go green untuk mengurangi limbah	Manajerial
3.	Kunjungan Malang	1. Kunjungan BPJS bagaimana bisa meningkat? 2. Potensi Klaim 3. Komunitas senam Geriatri megalami kenaikan 4. Data yang di ambil karu maupun manajemen harusnya sama	1. Kunjungan Rawat Jalan 14000 bukan 100% dari BPJS Kesehatan (Kunjungan BPJS 11.000 turun dari Bulan Januari) 2. Kunjungan yg naik dari Rawat Inap BPJS 3. Tindakan operasi turun dari bulan Februari 4. Tarif rawat jalan sudah mulai di perbaiki sehingga bisa meningkatkan tarif INACBGS 5. Primantara → penggajian kurir diperoleh dari hasil	Manajerial RS
		Saran Tindak Lanjut dari Pak Puguh	1. Identifikasi lagi spesialis yang belum praktik pagi (Home Doctor) untuk meningkatkan kunjungan 2. Tidak boleh memukul rata INACBGS bedakan mana yg top up maupun yg non top up sehingga bisa ketahuan mana yang bisa meningkatkan INACBGS 3. SOP agar dokter memahami fermentation. 4. Kecepatan eksekusi perlu ditingkatkan	Manajerial PT dan RS



		Saran Dokter Aslichah	1. Rawat inap tidak berpengaruh dengan kondisi libur yang banyak . Rawat jalan yang berpengaruh apabila banyak hari libur 2. Penambahan slot untuk Dokter Spesialis 3. Rujukan pasien harus dilaksanakan sesuai prosedur dan komunikasi yang efektif antar pasien dan petugas untuk mengurangi komplain.	Manajerial PT dan RS
4.	PHM	Bedah syaraf belum ada operasi, kendalanya apa?	1. Evaluasi bedah syaraf untuk RS tipe C → sehingga ada controlling dari BPJS untuk tarif INACBGS. Mempertahankan kunjungan rawat inap. Bedah syaraf di rujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap. apakah beda syaraf worth it? Tergantung bagaimana kita bisa kontrol di alihkan ke pelayanan lain.	Manajerial RS
		Kepala Ruang Penilaian Kinerja masih belum paham	Sosialisasikan kepada seluruh kepala ruang terkait penilaian kinerja	SDM dan Manajerial RS
		1. Operasi 2. Rujukan internal bagus untuk meningkatkan poli. 3. Penambahan dr. Spesialis masih belum ada Tindak Lanjut. 4. PHS butuh dr Orthopedi → mengingat kondisi dari dr. Orthopedi yg mengurangi jadwal 5. Bedah Syaraf 6. Kantin 7. Kuesioner Kessan dan Kepuasan pasien 8. Kontrol tarif Dokter Bedah	1. Mapping kembali terkait excision apakah sampai soft issue, muscle 2. Kita tidak boleh merujuk internal jika kita punya dokter spesialis di hari itu. Harus punya aturan klaim mana yang harus di ajukan ke BPJS? Apakah semua DPJP akan mendapatkan jasa pelayanan 3. Analisis utilitas poli untuk penambahan DPJP dan dr Orthopedi 4. Laporan terkait COB bisa di tampilkan di laporan bulanan	Manajerial RS

			5. Tolong di baca lagi terkait DPJP dan nilai casemix per rawat jalan. Dan amati mana yang perlu kita improve dalam satu kode INACBGS. 6. Bedah Syaraf traumatic tarifnya tinggi. Perlu adanya diskusi terkait pasien traumatic dan non traumatic. Bagaimana bedah syaraf bisa di pertahankan? Kabid harus bisa memahami dan menganalisis secara kritis 7. Ditegakkan terkait perokok di kantin, air detergen yang banyak juga dari kantin bisa di analisis untuk untuk penggunaan chemical 8. Persiapan BPJS andalan untuk trauma center. 9. Kuesioner Kessan pastikan di pantau dan TL nya harus ada 10. Bagaimana controlling tarif dengan dokter bedah agar tidak melebihi inacbgs dan dapat meningkatkan surplus → dibuatkan PPK	
5.	Beetu dan Primantara	Program Beetu dan Primantara bukan untuk menjadi battle	targetnya untuk menurunkan angka lama tunggu	Manajerial PT dan RS
6.	Programmer	1. Akan ada kemunduran target ketika ada progress dari vendor 2. Rekam medis dari Rawat jalan → belum terintegrasi RS RM harus bisa mengurutkan RM berdasarkan NIK 3. Diagnosis tidak ada inputan manual	1. Prioritaskan integrasi satu sehat walaupun ada kemunduran RS membantu komunikasi dengan BPJS → dokumentasikan progress programmer 2. Kendala migrasi data → NIK dan TT NIK → pastikan pasien terisi NIK nya bisa dilakukan kunci apabila tidak terisi dengan benar. 4. Bantu teman asuransi center untuk bridging ekclaim dan vkclaim untuk mempermudah tim asuransi center (fitur ICD	Programmer dan manajerial RS

			yang menguntungkan dokter baru agar bisa di eksekusi dan menjadi nilai jual untuk dokter baru. 7. Harus sudah ada Segmentasi SMF yang sudah punya HD maupun yang belum sehingga bisa kita eksekusi	
		Teknis dari SDM	1. SDM harus ada Langkah-langkah kebijakam untuk rekrut dokter baru 2. Harus tetap ada evaluasi kurang lebih satu minggu untuk mengetahui kepatuhan DPJP sebelum di tawarkan menjadi HD	Manajerial PT, SDM PT dan Direksi RS
		Strategi apabila dokter tamu jam praktik sama dengan HD	Sudah terjadi di PHS dan dilakukan pembagian sesuai kebijakan terkait pembagian pasien baru	Direksi RS
		Regulasi dan Kebijakan Home Doctor	1. Perlu adanya aturan yang di pertegas apabila ada kesengajaan pelanggaran oleh DPJP menjadi tanggung jawab DPJP bukan Rumah Sakit	Manajerial PT, SDM PT dan Direksi RS
		Perlu waspada terkait operasi Katarak di tumpuk pada satu hari. Karena BPJS sedang menyorot terkait operasi katarak yang di tumpuk	Perlu adanya aturan yang disesuaikan dengan utilitas RS dan sarana prasarana RS dalam melaksanakan operasi. RS harus memastikan jam operasi katarak. Sebagai catatan jadwal praktik dokter, jadwal visit dan jadwal operasi elektif tidak boleh berisan	Manajerial PT, SDM PT dan Direksi RS

Pemimpin Rapat
Komisaris Utama PT Disa Prima Medika



dr. Sadi Hariono, MMRS

Malang, 26 Maret 2024
Notulis



Adinda Lestari Putri, S.KM

Mengetahui
Direktur Utama PT. Disa Prima Medika




PT. DISA PRIMA MEDIKA
Endang Susilowati

DOKUMENTASI

